

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE CINCO FACETAS DE MINDFULNESS (FFMQ-SF)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de los 5 Mecanismos Nucleares de Atención Plena

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Cinco Facetas de Mindfulness - Versión Abreviada (FFMQ-SF).
Nombre Original (Inglés)	<i>Five Facet Mindfulness Questionnaire – Short Form (FFMQ-SF 24 items)</i>
Autores Originales	Drs. Ernst Bohlmeijer et al. (2011) a partir del modelo de Ruth A. Baer et al. (2006).
Adaptaciones Españolas	Asensio-Martínez et al. (2019); Cebolla et al. (2012), Universidad de Valencia.
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Multifactorial de Mindfulness (Baer).
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar abreviado de 24 reactivos con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 14 años). Estándar en programas MBSR, MBCT y clínica general.
Tiempo de Administración	4 a 6 minutos en autoadministración; 7 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico de acceso abierto para fines clínicos y de investigación académica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA ATENCIÓN PLENA

El FFMQ-SF sintetiza en una estructura empírica limpia de 24 ítems las cinco dimensiones integradas por Ruth Baer a partir de las principales escalas pioneras de mindfulness. Define la atención plena como la capacidad deliberada de dirigir la atención al momento presente sin juzgar y con una actitud de apertura y curiosidad radical.

Neurobiológicamente, el entrenamiento y la capacidad disposicional de mindfulness se asocian a cambios plásticos en redes neurales críticas: desacoplamiento y desactivación funcional de la Red por Defecto (DMN: precúneo y corteza prefrontal ventromedial), reduciendo la rumiación autorreferencial espontánea; potenciación de la conectividad frontoamigdalina facilitadora de la extinción del miedo; y engrosamiento cortical en la ínsula anterior y el córtex prefrontal dorsolateral, soporte de la interocepción y la autorregulación ejecutiva.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Faceta de Mindfulness	Ítems (24)	Rango Dir.	Definición Operativa y Fenomenológica
1. Observar (Observing)	1, 5, 9, 13 (4)	4 a 20	Atención perceptiva consciente a estímulos internos (sensaciones somáticas, pensamientos) y externos (sonidos, olores).
2. Describir (Describing)	2, 6, 10, 14, 18 (5)	5 a 25	Capacidad y fluidez para nombrar y expresar con palabras las experiencias emocionales sentidas.
3. Actuar con Conciencia	3, 7, 11, 15, 19 (5)	5 a 25	Focalización atencional plena en la actividad en curso, en contraste con el “piloto automático” y la distracción.
4. No Juzgar la Experiencia	4, 8, 12, 16, 20 (5)	5 a 25	Actitud de no enjuiciamiento hacia los propios pensamientos y emociones; aceptación del malestar.
5. No Reaccionar al Malestar	17, 21, 22, 23, 24 (5)	5 a 25	Capacidad de observar pensamientos difíciles o impulsos sin ser arrastrado por ellos; pausa reflexiva.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en adaptaciones españolas: alfa de Cronbach de 0.88 para la escala total (Asensio-Martínez et al., 2019); facetas: No Juzgar (0.84), Actuar con Conciencia (0.83), Describir (0.82), No Reaccionar (0.78) y Observar (0.74).
Estructura Factorial	El AFC ratifica el modelo jerárquico de 5 factores de primer orden y un factor general de mindfulness (CFI = 0.96, RMSEA = 0.048), con total equivalencia métrica frente a la versión original de 39 ítems.
Validez Concurrente	Correlaciones directas con bienestar psicológico, autocompasión (SCS) y regulación emocional (ERQ-RC); e inversas con depresión (PHQ-9), ansiedad (GAD-7), alexitimia y rumiación (RRS).
Sensibilidad al Cambio	Herramienta de referencia para medir ganancias terapéuticas pre-post en intervenciones basadas en mindfulness (MBSR, MBCT), exhibiendo incrementos significativos con tamaños de efecto d de Cohen > 0.80 .
Invarianza en Meditadores	Demuestra propiedades psicométricas sólidas tanto en personas sin entrenamiento previo como en practicantes experimentados de meditación.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se califica de 1 a 5 (1 = «Nunca o muy rara vez verdad», 2 = «Rara vez verdad», 3 = «A veces verdad», 4 = «A menudo verdad», 5 = «Muy a menudo o siempre verdad»):

- **Paso 1 (Inversión de Ítems Negativos):** Los reactivos redactados negativamente de las escalas **Actuar con Conciencia (3, 7, 11, 15, 19)** y **No Juzgar (4, 8, 12, 16, 20)** deben invertirse obligatoriamente: 1 $\rightarrow$ 5, 2 $\rightarrow$ 4, 3 $\rightarrow$ 3, 4 $\rightarrow$ 2, 5 $\rightarrow$ 1.
- **Paso 2 (Puntuaciones por Facetas):** Sumar los ítems de cada una de las 5 facetas (o calcular medias aritméticas dividiendo por el número de ítems, rango 1.0 a 5.0).
- **Paso 3 (Puntuación Total FFMQ-SF):** Suma de los 24 reactivos tras la inversión. Rango total: **24 a 120 puntos**. A mayor puntuación, mayor capacidad de atención plena y autorregulación.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (PUNTUACIÓN TOTAL)

Nivel Mindfulness	Rango Total	Perfil de Atención Plena	Conducta Asistencial Recomendada
Bajo / Reactivo	24 a 69	Piloto automático y autojuicio severo	Déficit de descentramiento. Inflexibilidad cognitiva. Indicación de entrenamiento formal MBSR/MBCT.
Moderado	70 a 89	Capacidad atencional media	Conciencia intermitente del presente; vulnerable a enganches reactivos ante estrés agudo. Psicoeducación.
Alto / Pleno	90 a 120	Mindfulness consolidado (≥ 90)	Excelente capacidad de no reactividad, aceptación y presencia consciente. Factor de resiliencia afectiva.

LA FACETA CRÍTICA: NO JUZGAR LA EXPERIENCIA INTERNA:

En pacientes psiquiátricos, la subescala de **No Juzgar** es el mediador clínico más potente de la remisión sintomática. Un puntaje bajo en No Juzgar ($M < 2.5$) predice recaídas depresivas independientemente de cuánto medite el sujeto, ya que el paciente utiliza la observación para hipervigilar y criticar sus estados afectivos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADA EN MINDFULNESS

INTERVENCIÓN MODULAR DIRIGIDA POR FACETAS DEL FFMQ-SF:

- **Si Actuar con Conciencia es bajo ($M < 2.5$):** Entrenar ejercicios informales de mindfulness en actividades cotidianas (comer conscientemente, ducharse con atención a sensaciones) para romper el automatismo.
- **Si No Juzgar es bajo ($M < 2.5$):** Entrenamiento intensivo en autocompasión (mindful self-compassion) y defusión cognitiva; aprender a tratar los pensamientos autocríticos como “ruido de la mente” y no hechos reales.
- **Si No Reaccionar es bajo ($M < 2.5$):** Práctica de pausas deliberadas tipo STOP (Stop, Toma aire, Observa, Procede) ante impulsos de actuar o contestar agresivamente.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN RECAÍDAS DEPRESIÓN MAYOR

Paciente: Varón de 42 años, directivo de empresa, con antecedentes de 3 episodios de depresión mayor reactiva. Acude a consulta remitido para prevención de recaídas refiriendo que cualquier bajada leve de ánimo matutina lo aterroriza y lo lleva a autoacusarse de ser «un débil que va a volver a hundirse».

Evaluación Basal FFMQ-SF: Total = **52 / 120 puntos** (Nivel bajo reactivo; percentil 10).

• **Medias por Faceta (1 a 5):** Observar = 3.2; Describir = 2.8; Actuar con Conciencia = **1.8**; No Juzgar = **1.4** (Extremo autojuicio punitivo); No Reaccionar = **1.8** (reactividad panica inmediata ante la tristeza).

Formulación Clínica: Reactivación diferencial del patrón rumiador depresivo. La no aceptación de la tristeza transitoria normal dispara una cascada secundaria de juicios y alarma que reenciende el episodio depresivo mayor.

Tratamiento MBCT y Evolución: Programa MBCT de 8 semanas en grupo. Aprendió a relacionarse con los pensamientos como eventos mentales (“tengo el pensamiento de que voy a recaer, pero es solo un pensamiento”). Al mes 4: FFMQ-SF Total subió a **94 puntos** (No Juzgar subió a 4.0; No Reaccionar a 3.8), manteniéndose libre de recaídas a los 12 meses de seguimiento.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN

LA PARADOJA DE LA FACETA OBSERVAR EN NO MEDITADORES

En sujetos sin práctica de meditación previa, una puntuación alta en Observar sin suficiente No Juzgar suele reflejar hipervigilancia somática ansiosa o hipocondría en lugar de mindfulness genuino.

REGLA DE INVERSIÓN EN FFMQ-SF

Verificar minuciosamente la inversión de los 10 reactivos formulados negativamente (todos los de Actuar con Conciencia y No Juzgar). Omitir su inversión invalida por completo el cálculo del perfil psicométrico.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. *Assessment*, 13(1), 27–45.
2. Bohlmeijer, E., ten Klooster, P. M., Fledderus, M., Veehof, M., & Baer, R. (2011). Psychometric properties of the Five Facet Mindfulness Questionnaire—Short Form (FFMQ-SF). *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 18(4), 308–320.
3. Cebolla, A., García-Palacios, A., Soler, J., Guillen, V., Baños, R., & Botella, C. (2012). Psychometric properties of the Spanish validation of the Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ). *The European Journal of Psychiatry*, 26(2), 118–126.
4. Asensio-Martínez, Á., et al. (2019). Psychometric properties of the Spanish version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire-Short Form (FFMQ-SF) in the general population. *Mindfulness*, 10(6), 1144–1155.